HALK SAĞLIĞI

Yrd. Doç Dr SEDA BEHLÜL

Dersin amacı

- Dersin amacı toplumun farklı kesimlerinde sağlığın belirleyicilerin rolünü ve halk sağlığı yaklaşımını, çalışma alanlarını, sağlık sorunlarında halk sağlığı bakış açısını ve epidemiyolojinin halk sağlığındaki yerini tartışabilmektir.

Toplum

- Toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için etkileşen , belli bir coğrafi mekanda yaşayan ve ortak bir kültürü paylaşan pek çok sayıdaki ***bireyin*** oluşturduğu ***birliktelik.***

Toplumun Özellikleri

- Toplam nüfus
- Ortak bir coğrafi mekan
- İşlevsel olarak farklılaşmış temel gruplar
- Kültürel olarak benzer gruplar
- Toplumu oluşturan insanlar arasında düzenli karşılıklı ilişkiler vardır

Birey

- Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

Sağlık

TANIM

- Sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir.

Sağlığın 3 Temel Ölçütü

- 1- **Bedensel iyilik:** Vücudu oluşturan doku ve organlarda eksiklik, işlev bozukluğu, mikrop taşıma gibi durumların olmaması hali.
- 2- **Ruhsal iyilik:** Yaşına uygun olarak düşünebilen, düşündüklerini anlaşılır şekilde ifade edebilen, başkalarını anlayabilen, yerinde ağlamasını ve gülmesini bilen, güçlüklerle mücadele edebilen, koşullara uygun hareket edebilen, başarılarda mutlu olup başarısızlıkları kabullenebilen, kendisiyle barışık olma hali.
- 3- **Sosyal iyilik:** Nerede, nasıl davranacağını ve sorumluluklarını bilen, insanlarla iyi ilişkiler içinde olup büyüğünü, küçüğünü severek hoşgörülü davranan, çevresiyle barışık olma halidir.

Hastalık

- **Tıbbi modele göre hastalık,** Belirtilerle kendini gösteren patolojik tablodur. İnsan bedenindeki işlevsizlikler organizmadaki biyokimyasal değişmelerle anlaşılır. Hastalık, bakteri, virüs, hatalı gen ya da kazalardan kaynaklanır. Bu görüş insanı sosyal çevresinden, ilişkilerinden ve kimliğinden soyutlanarak ele alınmasına ve bir nesne gibi algılanmasına neden olur.
- **Sosyolojik modele göre hastalık;** Hastalık kültürel ve sosyal yapıdan kaynaklanır. Bu model sağlığı geliştirmek için yaşam standardı üzerine yoğunlaşmak gerektiğini savunur (Ekonomik, eğitim vb.).

Toplum Sağlığı Önemi

Sağlıklı Birey



Sağlıklı Toplum

MERVYN SUSSER (1985)

"Toplumlar hastalıklarını kısmen kendileri yaratır."

Toplum Sağlığı

- Nedir?
  - Toplumun örgütlü çabası ile hastalıkların önlenmesi, yaşamın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesi eylemini gerçekleştiren bir sanat ve bilimdir.

Toplum Sağlığı

- Topluma odaklıdır.
- Çevre, insan davranışı ve yaşam biçimine yönelik müdahalelerle tıbbi bakımı içerir.
- Bir çalışma alanı olarak tıp mezunlarıyla birlikte sağlıkla ilgili diğer disiplinlerin mensuplarına da açıktır.

Toplum Sağlığı

- Genetik ve bulaşıcı hastalıklar, ana ve çocuk sağlığı, çevre faktörüne bağlı sağlık sorunları, yaşam biçimi, kronik hastalıklar, kaza ve şiddete bağlı sağlık sorunları halk sağlığı çalışmalarının odağını oluşturmaktadır.

- Bütün bu s ak, günümüz sağlık siste etlerini çok disiplinli b halk sağlığının en önemli



- Bundan yaklaşık 100 yıl önce tıbbi konular biyomedikal yaklaşımla ele alınır tifo, çiçek veba vb. epidemik hastalıklar etken, hasta ve çevre ilişkisinde değerlendirilirdi.

- Bu yaklaşımda hastalıklar tamamen fizyolojik ve çevresel faktörlerin sonuçları gibi düşünülür ve bir etkenin fizyolojik faaliyetleri aksatması veya bozması olarak tanımlanmaktadır.

- Günümüzde ise bu yaklaşıma davranışsal, sosyal ve ekonomik boyutlar da eklenmiştir.
  - Örneğin AIDS ciddi ölüm riski taşıyan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığa HTLV-III retro virüsü sebep olmaktadır. Tedavide biyomedikal yaklaşım söz konusudur. Ancak bu virüsün bulaşması, ciddi oranda bireyin sosyal, kültürel, eğitimsel ve davranışsal yapısı ve seçimleri ile ilgilidir ve halk sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.

Toplum sağlığının amaçlari nelerdir? - 1

Tüm toplumda hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi,

Tek tek hastaları tedavi etmeyi değil, insan gruplarının sağlığını korumak,

Toplumun sağlık ihtiyaçlarının belirlemek, ölçmek, izlemek ve mücadele başlatmak,

Toplum sağlığının amaçlari nelerdir? - 2

- Sağlıklı yaşam tarzlarını ve sağlıklı alışkanlıklarını teşvik etmek,
- Temel sağlık politikalarını tasarlamak, geliştirmek ve desteklemek,
- Nitelikli ve maliyet-etkin bir toplum sağlığı uygulaması ve sağlık hizmet sunumu sağlamak.

Sağlığın geliştirilmesi - 1

- Tüm dünyadaki insanların sosyal ve ekonomik yönden verimli bir hayat sürdürebilmesi için hükümetlerin üstlenecekleri rollere 1977 yılındaki Dünya Sağlık Asamblesi'nde dikkat çekilmiştir.
- 1978 yılında Alma-Ata Konferansı'nda "21. Yüzyılda Herkese Sağlık" politikasının temelleri atılmıştır.
- Dünya Sağlık Örgütü' nün 1998 yılındaki 48. Avrupa Bölge Komite Toplantısı'nda Herkese Sağlık politikaları "21. Yüzyılda 21 Hedef" sloganıyla resmen kabul edilmiştir.

Sağlığın Geliştirilmesi - 2

- 1978 yılında bu anlayışı temel alan WHO (Dünya Sağlık Örgütü) birinci basamak sağlık hizmetlerinde esas olarak kabul edilebilir sağlık düzeyinin gelecekteki sosyal gelişmelerin ve adaletin ruhunu taşıyarak tüm dünyada var olmasını hedef olarak seçmiştir.
- 1979 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kasım toplantısında sağlığı gelişmişliğin bir parçası olarak gören Alma ata deklarasyonunu yayımlamıştır. Böylece WHO, UNICEF ve BM ilgili birimleri 2000'li yıllarda herkese sağlık» stratejisi kapsamında ortak bir çatı altında toplanmıştır.

Sağlığın Geliştirilmesi - 3

- 1986 yılında Kanada Ottowa da yapılan toplantı da «Sağlığı yükseltme politikası» «herkese sağlık» sloganıyla kabul edilmiştir. (Ottawa Bildirgesi)
- **Sağlığın geliştirilmesi**
  - Sağlığın korunması kavramının daha geniş bir bakış açısıyla ele alındığı bir yaklaşım olup sağlığa yönelik herhangi bir davranış ve yaşam durumu için, eğitim, örgütsel, ekonomik ve çevresel desteklerin bileşimi olarak tanımlar.
  - Sağlığı geliştirme bireye yönelmenin yanı sıra, fizik ve sosyal çevreye müdahaleleri de kapsar.
  - Çevresel müdahaleler kamu politikalarını, destekleyici çevre yaklaşımını, toplum katılımını, kişisel becerilerin geliştirilmesini, sağlık hizmetlerinin yeni gereksinimlere uyum sağlamasına öncelik vermelidir.

Sağlığın Geliştirilmesi - 4

- Sağlığın geliştirilmesi için *Ottawa Bildirgesi'nin* öncelik verdiği konular
  1. Sağlıklı kamu politikalarının oluşturulması,
  2. Destekleyici bir çevrenin yaratılması,
  3. Toplum katılımının güçlendirilmesi,
  4. Kişisel becerilerin-yeteneklerin geliştirilmesi,
  5. Sağlık hizmetlerinin gereksinimlere uyum sağlaması

21 Hedef

1- Avrupa bölgesinde Sağlık Dayanışması

- Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler arasında sağlık eşitsizliklerinin azaltılması amaçlanmaktadır.
- "2020 yılına kadar, Avrupa Bölgesindeki üye ülkeler arasında sağlık durumundaki farklılık, en az 1/3 azaltılmalıdır.
  - Avrupa ülkelerinin 1/3ünde çok yüksek ve 1/3ünde çok düşük olan yaşam beklentisi düzeyleri arasındaki fark en az %30 azalmalıdır.
  - Hastalık, sakatlık ve ölümle ilgili en önemli göstergelerdeki ülkelerarası farklılık, dezavantajlı ülkelerin koşulları hızla düzeltilerek azaltılmalıdır.

21 Hedef

- 2- Sağlıkta Hakkaniyet
- 2020 yılına kadar, ülkelerdeki sosyo-ekonomik gruplar arasında sağlıkla ilgili farklılık, dezavantajlı grupların sağlık düzeylerini geliştirerek, tüm üye Ülkelerde en az dörtte bir azaltılmalıdır.
- 3- Yaşama Sağlıklı Başlanması
- 2010 yılına kadar, bölgedeki yeni doğanların, bebeklerin ve okul öncesi yaşlardaki çocukların hepsinin yaşama sağlıklı başlayarak daha sağlıklı olmaları sağlanmalıdır.

21 Hedef

- 4- Gençlerin Sağlığı
- 2010 yılına kadar, bölgedeki gençler daha sağlıklı olmalı ve toplumdaki rollerini daha iyi yerine getirmelidirler.
- 5- Yaşlıların Sağlığı
- 2020 yılına kadar, 65 yaşın üzerindeki insanlar sağlık potansiyellerinin tam yerinde olması fırsatına sahip olmalı ve aktif sosyal rol oynayabilmelidir.

21 Hedef

- Hedef 6: Ruh Sağlığının Geliştirilmesi:
- “2020 yılına kadar , insanların psikososyal iyilik hali geliştirilmeli ve ruh sağlığı sorunları olan insanların ulaşabileceği daha kapsamlı hizmetler oluşturulmalıdır.”
- Hedef 7:
- “2020 yılına kadar, eradikasyon, eliminasyon ya da halk sağlığı açısından önemli olan enfeksiyon hastalıklarının kontrolü programlarının sistemli olarak uygulanmasıyla bulaşıcı hastalıkların sağlığa olumsuz etkileri azaltılmalıdır.”

21 Hedef

- Hedef 8: Bulaşıcı olmayan hastalıkların azaltılması
- "2020 yılına kadar, tüm bölgede en önemli kronik hastalıklara bağlı hastalık, sakatlık ve erken ölüm mümkün olan en düşük düzeylere düşürülmelidir."
- Hedef 9: Şiddet ve Kazalar Sonucu Yaralanmaların Azaltılması
- "2020 yılına kadar, Bölgede şiddet ve kazalar sonucu oluşan yaralanmalar, sakatlık ve ölümlerde sürekli ve belirgin bir azalma olmalıdır."

21 Hedef

- Hedef 10: Sağlıklı ve Güvenli Fizik Çevre
- "2015 yılına kadar bölgede insan sağlığına zarar veren çevre kirliliği maruziyet düzeyleri uluslararası standartları aşmamalı ve insanlar daha güvenli bir fiziksel evrede yaşamalıdırlar."
- Hedef 11: Sağlıklı Yaşam
- "2015 yılına kadar, toplumdaki insanlar sağlıklı yaşam biçimlerini benimsemelidirler.

21 Hedef

- Hedef 12: Alkol, ilaç ve tütüne bağlı zararın azaltılması
- "2015 yılına kadar, bağımlılık yapan tütün, alkol ve psikoaktif ilaçların tüketimini sağlık üzerindeki olumsuz etkileri tüm üye ülkelerde belirgin şekilde azaltılmalıdır."
- Hedef 13: Sağlıklı Çevreler
- "2015 yılına kadar, Bölgedeki insanlar, evde, okulda, iş yerinde ve yaşadıkları ortamlarda sağlıklı fiziksel ve sosyal çevrelerde yaşama fırsatlarına daha fazla sahip olmalıdırlar."

21 Hedef

- Hedef 14: Çok sektörlü sağlık sorumluluğu
- “2020 yılına kadar, tüm sektörler sağlıkla ilgili sorumluluklarını kabul etmelidir.”
- Hedef 15: Entegre Sağlık sektörü
- “2010 yılına kadar, bölgedeki insanlar, esnek ve duyarlı bir hastane sistemi ile desteklenen aile ve topluma dayalı temel sağlık hizmetlerine daha iyi ulaşabilmelidir.”

21 Hedef

- Hedef 16: Hizmette Kalite Yönetimi
- 2010 yılına kadar, üye ülkeler topluma dayalı hizmet programlarından klinik düzeyde bireysel hasta bakımına kadar hizmet sektörü yönetiminin sağlık sonuçlarına yönelik olmasını sağlamalıdır,
- Hedef 17: Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Kaynaklarının Tahsisi Edilmesi
- 2010 yılına kadar, üye ülkeler eşit ulaşım, maliyet etkinlik, dayanışma ve optimum kalite ilkelerini temel alan sağlık hizmetleri için sürdürülebilir finansman ve kaynak tahsisi mekanizmalarına sahip olmalıdır.

21 Hedef

- Hedef 18: Sağlık hizmetlerine yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesi
- "2010 yılına kadar, tüm üye ülkeler, sağlık profesyonellerinin ve diğer sektörde çalışanların sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik uygun bilgi, tutum ve becerileri kazanmalarını sağlamalıdır.
- Hedef 19: Sağlıkla ilgili Araştırma ve Bilgi
- "2005 yılına kadar, tüm üye ülkeler herkes için sağlığı destekleyen bilginin daha iyi kazanılmasını, etkili kullanılmasını ve yayınlanmasını destekleyen sağlık araştırma, bilgi ve iletişim sistemlerine sahip olmalıdır.

21 Hedef

- Hedef 20: Sağlık İçin tarafların harekete geçirilmesi
- “2005 yılına kadar, herkes için sağlık politikalarının uygulanmasında sağlık için ittifak ve ortaklıklarda bireyler, kamu ve özel sektörlerin tamamındaki gruplar ve kuruluşlar, sivil toplum angaje edilmelidir.
- Hedef 21: Herkes için Sağlık Konusunda Politikalar ve Stratejiler
- “2010 yılına kadar, tüm üye ülkelerin ülke, bölge ve yerel düzeylerde herkes için sağlık politikaları olmalı ve uygun kurumsal altyapılar, yönetimsel süreçler ve yenilikçi liderlikle desteklenerek uygulanmalıdır. “

Halk sağlığı konusunda günümüze kadar elde edilen başarılar

- Gelişen sanitasyon devrimi, bireysel hijyen standartları gelişimi ve gelişen yaşam koşulları
  - İshalden kaynaklanan hastalıkların azaltılması
- Annelerin bebek bakımı bilgilerinin arttırılması
- Aşıların bulunması
  - Çiçek hastalığında olduğu gibi
    sağlanması
  - Tüberküloz, difteri, kızamık gib
    hemen hemen veya kısmen kor



Halk sağlığI konusundakİ başarısızlıklar

- Grip, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (AIDS, hepatit B)
- Orta yaş ve yaşlı grupların sağlık sorunları
  - İskemik kalp hastalıkları, mental bozukluklar, kanser, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) vb
- Trafik kazaları
- Nüfus artışı yoğunluğu, doğum kontrol
- Sigara, alkol ve ilaç bağımlılığı
- Sosyal sorunlar
- Eğitimsizlik